



01.05.2026 / Новости



РАННИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РИСКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Перевод: Вирт К. О.





корректировки разных полигенных показателей именно риск РДВГ сохранял независимую связь с большинством изученных признаков, что делает его главным генетическим сигналом в этой выборке.

За последнее десятилетие психиатрическая генетика убедительно показала, что большинство психических расстройств имеют полигенную природу. Это означает, что риск не определяется одной «болезненной мутацией», а складывается из большого числа генетических вариантов, каждый из которых вносит очень небольшой вклад. Вопрос в том, как такой риск проявляется до формирования клинически оформленного расстройства и можно ли заметить его уже в обычной школьной популяции.

Авторы использовали данные испанской популяционной когорты INSchool, включавшей 4709 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, со средним возрастом 10 лет. В выборке было 45% девочек. Полигенные шкалы риска рассчитывали для РДВГ, расстройств аутистического спектра, биполярного расстройства, депрессии, шизофрении и тревожных расстройств. Эмоциональные и поведенческие трудности оценивались по данным родителей, учителей и самих участников с помощью нескольких валидизированных опросников, а статистический анализ проводился с использованием линейных смешанных моделей.

Главный результат исследования состоит в том, что из 54 изученных признаков 35 сохраняли статистически значимую связь как минимум с одним полигенным показателем после поправки на множественные сравнения. Эти ассоциации касались прежде всего полигенного риска РДВГ, а также, в меньшей степени, риска расстройств аутистического спектра и депрессии. Для тревожных расстройств, биполярного расстройства и шизофрении убедительных общих ассоциаций в основной модели обнаружено не было.

Особенно важно, что полигенный риск РДВГ оказался связан с широким, по сути трансдиагностическим спектром трудностей. Это были не только проблемы внимания или гиперактивность, но и более общие эмоциональные и поведенческие нарушения, причём этот сигнал воспроизводился по данным всех трёх информантов. Такой результат хорошо согласуется с представлением о том, что



Отдельный интерес представляет анализ по полу. В целом основные результаты сохранялись и у мальчиков, и у девочек, но некоторые связи выглядели пол-специфичными. Наиболее заметно это проявилось для полигенного риска шизофрении, который показал более выраженные эффекты у мальчиков в родительских оценках. Это не означает, что риск шизофрении уже в детстве «проявляется как шизофрения», но указывает на возможность разных траекторий ранней психопатологической манифестации в зависимости от пола.

Почему это важно

Эта работа важна потому, что она смещает разговор о психиатрической генетике от абстрактных геномных ассоциаций к реальной детской клинике. Полигенный риск не «предсказывает диагноз» в прямом смысле и тем более не работает как индивидуальный тест для школьника. Но он показывает, что генетическая уязвимость уже в детстве может проявляться через широкий спектр эмоциональных и поведенческих трудностей, заметных не только родителям, но и учителям, и самим детям. Для детской психиатрии особенно значим вывод о центральной роли РДВГ-связанного генетического сигнала. Это ещё раз подчёркивает, что РДВГ нельзя понимать только как расстройство внимания и поведения. На уровне развития он может быть одной из ключевых осей, через которую в раннем возрасте манифестирует более общая психопатологическая уязвимость.

Что это меняет

Исследование поддерживает трансдиагностический взгляд на детскую психопатологию, в котором ранние эмоциональные и поведенческие трудности не всегда принадлежат одной будущей нозологии. Генетический риск, по-видимому, проявляется сначала как широкий фенотип уязвимости, а уже позже может кристаллизироваться в более узнаваемые клинические синдромы. Одновременно эта работа хорошо показывает и границы нынешней психиатрической генетики. Эффекты полигенных показателей статистически значимы, но невелики, а значит, речь пока идёт не о клиническом инструменте индивидуального прогнозирования, а



doi:10.1016/j.jaac.2025.06.012.

Перевод: Вирт: К. О,

« Previous Post: На пути к DSM-6:
пересечение ОКР и психоза

Next Post: Новости лечения
психических расстройств за апрель
2026 »

О Пин